

Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Acil Durumlar İçin Prosedürel
ve Görsel Rehber



Önce İlkyardımcı Güvenliği ve Biyomekanik



Acil Taşıma Temel İlkesi: Altın Kural



Hasta/yaralının yeri değiştirilmemeli ve dokunulmamalıdır. Mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir.



Sadece olağanüstü bir tehlike söz konusuysa (yangın, patlama, solunum durması) acil taşıma zorunludur.

En Az 6 Destek Noktası

Taşıma işlemi, "Baş-Boyun-Gövde" eksenini kesinlikle bozulmadan yapılmalıdır.



Sürükleme Yöntemleri



Acil Çıkarma

Bilinç Kapalı/Ağır

Çok kilolu kişilerin taşınmasında veya dar, geçiş güçlüğü olan bölgelerden çıkarmada kullanılır. Mümkünse altına battaniye serilmelidir.



Ayak bileklerinden tutarak sürükleme.



Koltuk altından tutarak sürükleme.

Araç İçi Acil Çıkarma: Rentek Manevrası



Acil Çıkarma

Araç İçi

1

Kaza ortamı (yangın, patlama) değerlendirilir, ayakların pedala sıkışmadığından emin olunur, emniyet kemeri açılır.

2

Omuzlara dokunarak "İyi misiniz?" diye sorulur (Bilinç kontrolü). Göğüs hareketleri izlenir (Solunum kontrolü). Solunum yoksa işleme başlanır.

3

Yan taraftan yaklaşılr; bir elle kol, diğer elle çene kavranarak boyun tespit edilir.

4

Baş-boyun-gövde hizası kesinlikle bozulmadan hasta araçtan dışarı çekilir.

5

Yavaşça yere veya doğrudan sedyeye yerleştirilir.

Tek Kişilik Taşıma (Hafif ve Bilinci Açık Hastalar)



Kucakta Taşıma

- Bir elle dizlerin altından, diğer elle sırtından (gövde ağırlığı yüklenerek) kavranır.
- Yaralı kollarını ilkyardımcının boynuna dolar (güvende hissetmesi için). Ağırlık dizlere verilerek kalkılır.



■ Kısa Mesafe

Bilinç Açık/Hafif



Omzundan Destek Alma

- Yürüyebilecek durumdaki hafif hastalar içindir.
- Yaralının bir kolu ilkyardımcının boynuna dolandır. İlkyardımcı boşta kalan kolu ile hastanın belinden tutarak destekler. (Not: İki kişiyle de yapılabilir).

Tek Kişilik Taşıma (Ağır veya Bilinci Kapalı Hastalar)

x1

Kısa Mesafe

Bilinç Kapalı/Ağır



Sırtta Taşıma (Bilinçli Hasta)

- İlk yardımcı hastaya sırtı dönük çömelir ve bacaklarını kavrar.
- Hastanın kolları ilkyardımcının göğsünde birleştirilir, ağırlık dizlere verilerek kalkılır.



İtfaiyeci Yöntemi / Omuzda Taşıma (Bilinçsiz Hasta)

- Sol kol ile omuzdan tutularak hasta oturtulur.
- Çömelerek sağ kol bacakların arasından geçirilir, vücut sağ omuza alınır.
- Sol el ile hastanın sağ eli tutulur. İlk yardımcıının bir kolu boşta kalır (merdiven/destek için idealdir).

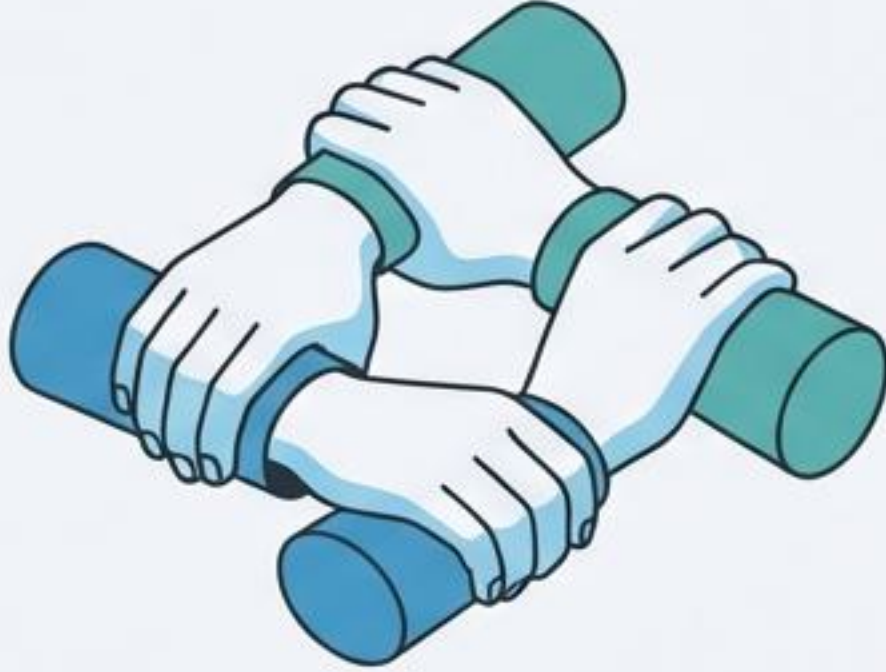
İki Kişilik Taşıma: Altın Beşik Yöntemi

Ciddi yaralanması olmayan ve taşıma sırasında kollarıyla destek olabilen hastalar içindir.

x2

Ekip Taşınması

Bilinç Açık



İki Elle Beşik

İlk yardımcının birer eli birbirlerinin omzunda, diğer elleriyle birbirlerinin bileklerini kavrayarak oturak oluştururlar.



Üç Elle Beşik

Birinci kişi bir eliyle ikincinin omzunu, diğer eliyle bileğini tutar. İkinci kişi kendi bileğini ve diğerinin bileğini kavrar.



Dört Elle Beşik

Her iki ilkyardımcı bir eliyle kendi bileğini, diğer eliyle karşıdakinin bileğini kavrayarak tam bir kare kilit oluşturur.

Ekip Taşıması: Kollar/Bacaklar ve Sandalye

x2

Ekip Taşıması



Kollar ve Bacaklardan Tutarak (Hızlı Aktarım)

- Bir ilkyardımcı hastanın arkasına (baş tarafına) geçip koltuk altlarından kavrar.
- İkinci ilkyardımcı sırtı hastaya dönük bacaklar arasına çömelip diz altlarından tutar.



Sandalye İle Taşıma (Merdiven İçin)

- Bilinci açık hastalar için merdiven inip çıkarken en pratik yöntemdir.
- Bir kişi sandalyeyi arkadan (oturma yerine yakın), diğeri ön bacakların en alt kısmından sıkıca kavrar.

Sedyeye Yerleřtirme: Kařık Teknięi

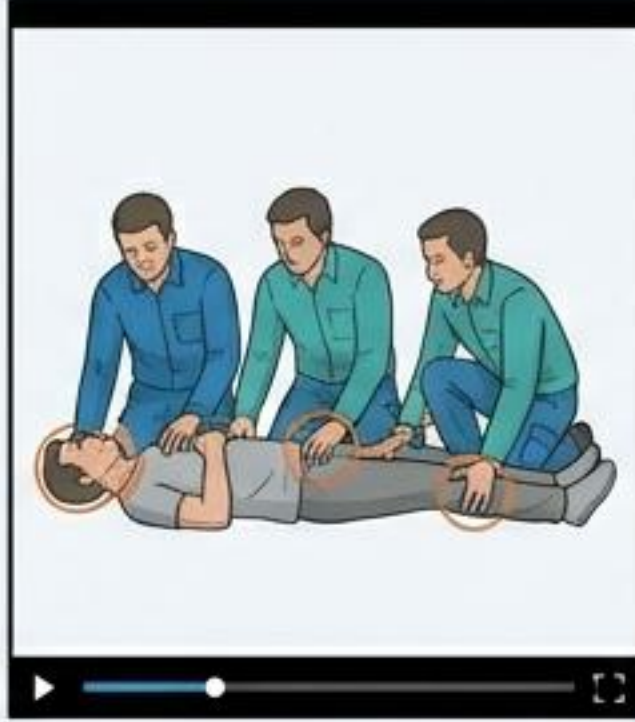
x3

Sedye Y¼kleme

Tek Taraftan Ulařım



Adım 1: Üç ilkyardımcı, hastanın tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çöker. Hastanın elleri göğsünde birleştirilir.



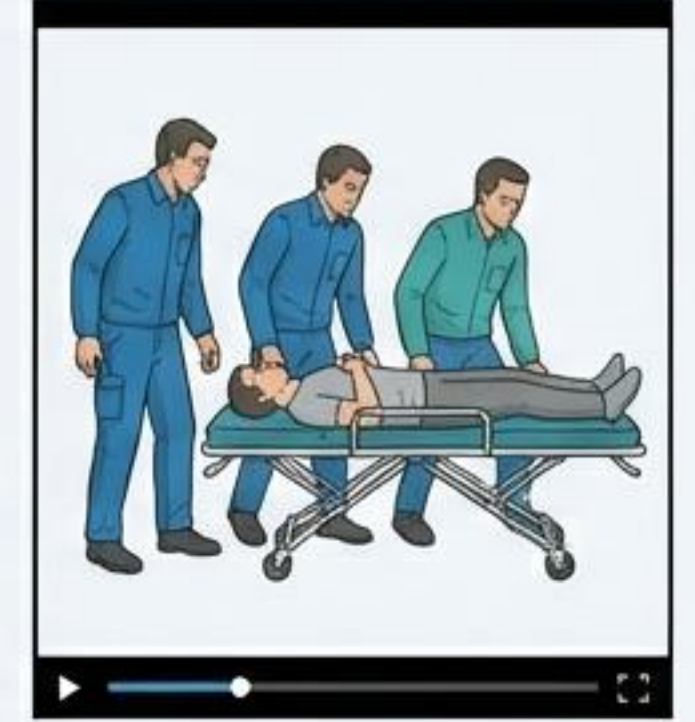
Adım 2: 1. kiři bař ve omuzdan, 2. kiři sırtın altı ve uyluktan, 3. kiři diz altı ve bileklerden ellerini hastanın altından geçirerek kavrar.



Adım 3: Bař kısmındaki ilkyardımcının komutuyla hasta aynı anda dizlerin üzerine kaldırılır.



Adım 4: Tek bir uyumlu hareketle hasta göğüslere doęru çevrilir (yaklařtırılır).



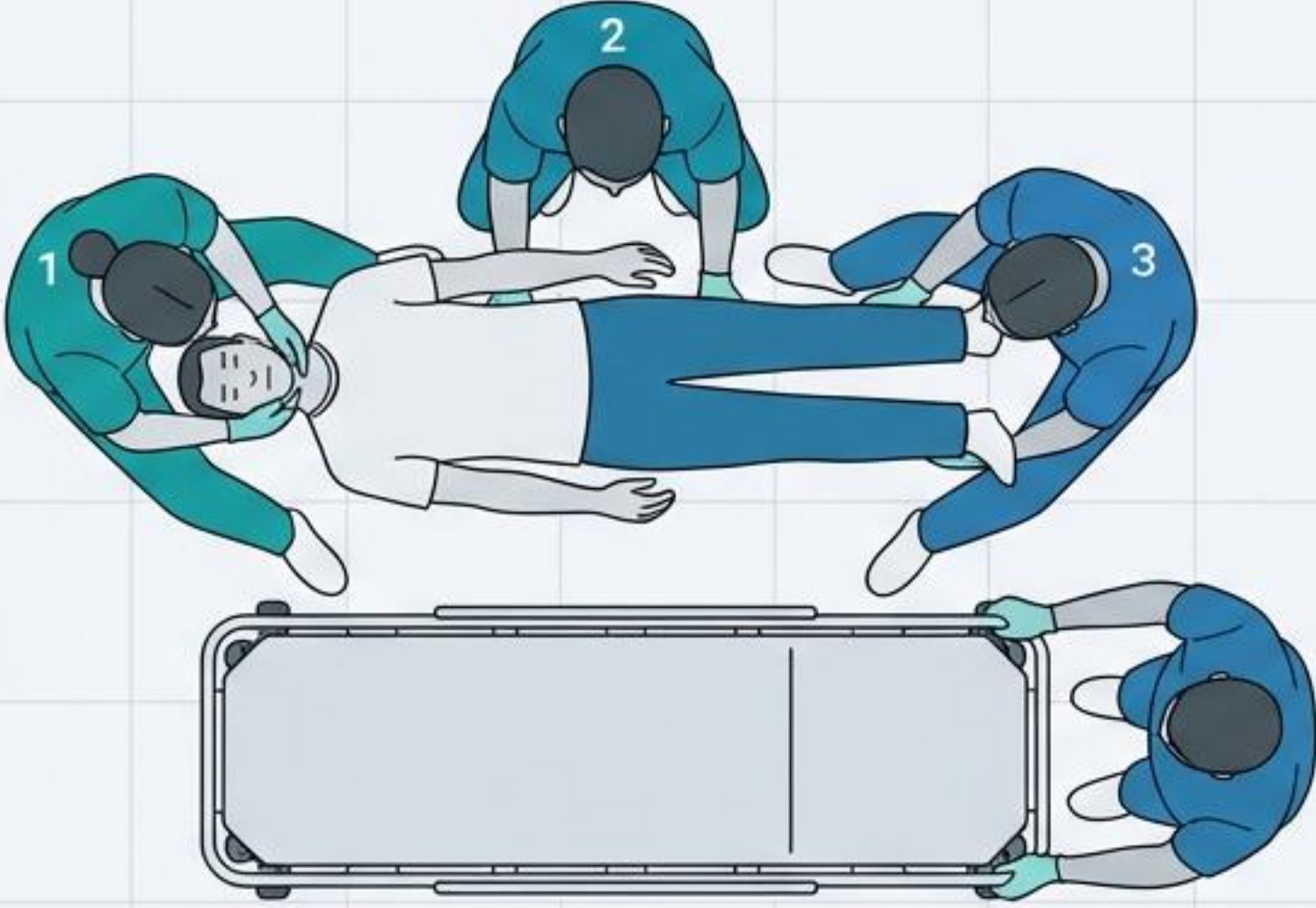
Adım 5: Uyumlu şekilde ayaęa kalkılır ve aynı anda düzg¼nce sedyeye bırakılır.

Sedyeye Yerleştirme: Köprü ve Karşılıklı

x3-4

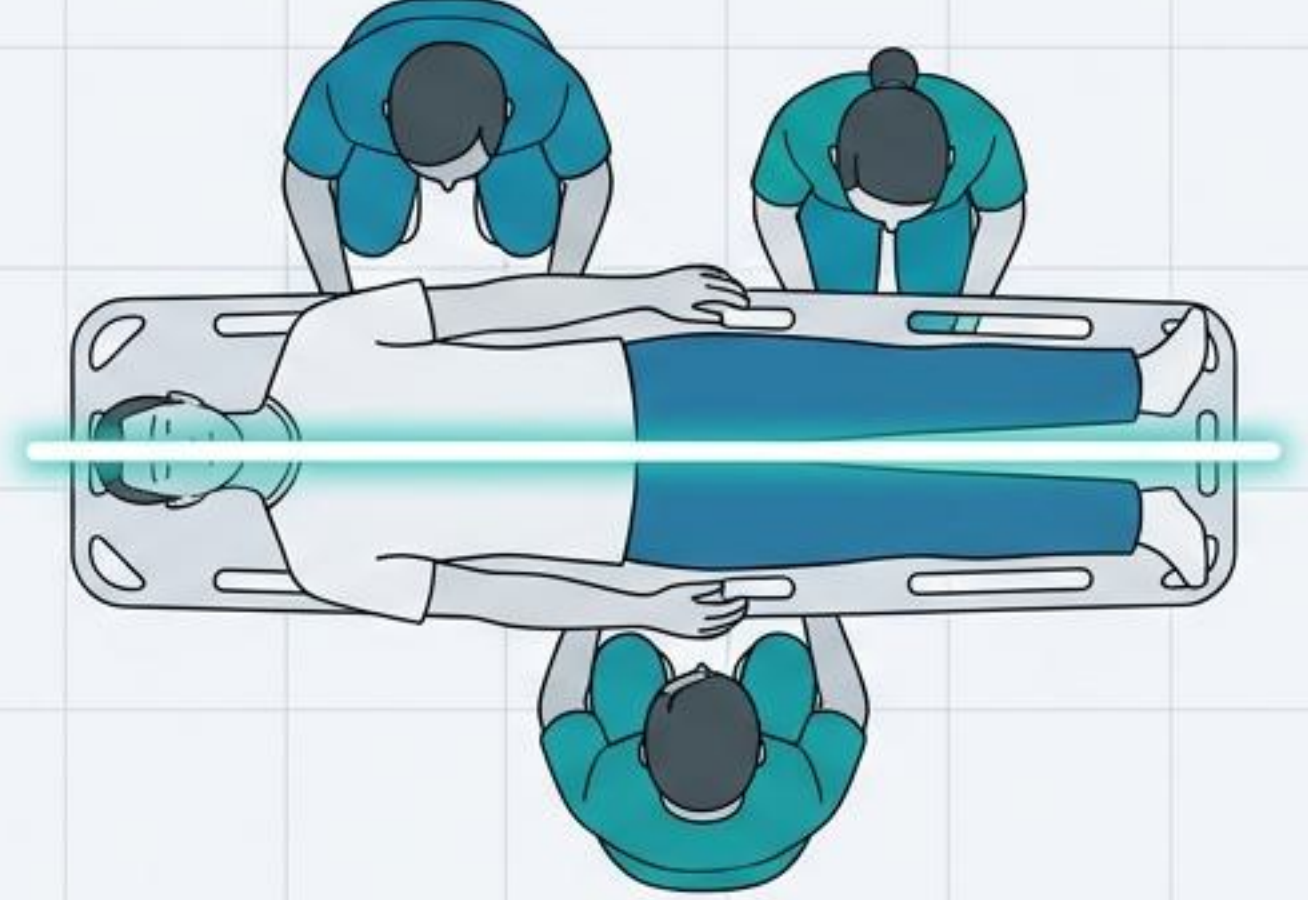
Sedye Yükleme

Omurilik Şüphesi (Karşılıklı)



Köprü Tekniği (İki Taraftan Ulaşım - 4 Kişi)

- Üç kişi bacaklarını açıp hastanın üzerine çömelir (1. kişi baş/ense, 2. kişi kalça, 3. kişi diz altı).
- Komutla hasta kaldırılırken, 4. kişi sedyeyi bacaklar arasından iterek yerleştirir.



Karşılıklı Durarak Kaldırma (Omurilik Yaralanma Şüphesi - 3 Kişi)

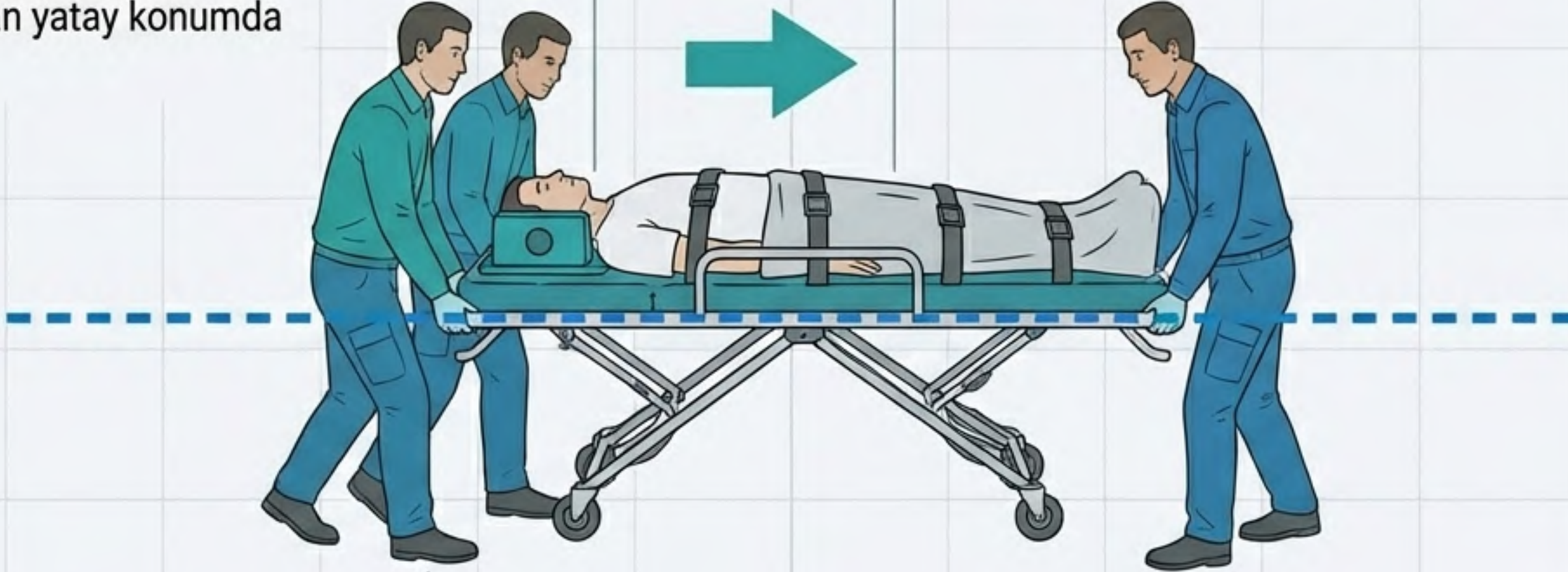
- İki kişi göğüs hizasında karşılıklı diz çöker, üçüncü kişi dizler hizasında durur.
- Baş kısımdakiler kollarını baş-boyun eksenini koruyacak şekilde sırtı yerleştirir.
- Komutla hasta tamamen düz/yatay olarak kaldırılıp sedyeye yerleştirilir.

Sedye İle Taşıma Protokolleri

☐ Sedye Protokolü

Yön ve Konum: Hastanın başı daima gidiş yönünde olmalı ve sedye her zaman yatay konumda tutulmalıdır.

Sabitleme: Hasta mutlaka battaniye/çarşaf ile sarılmalı ve düşmeyi önlemek için sedyeye bağlanmalıdır.



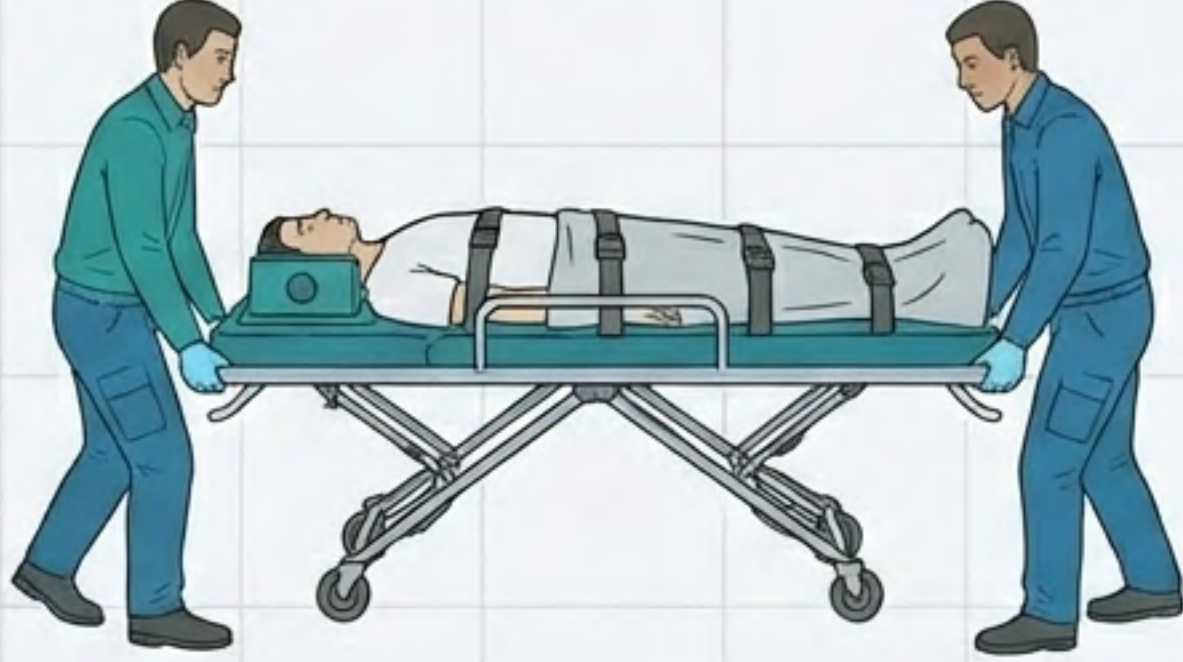
Adım Senkronizasyonu: Öndeki ilkyardımcı sağ ayağıyla, arkadaki sol ayağıyla yürümeye başlamalıdır (Dönüşümlü adımlar sarsıntıyı önler).

Liderlik: Güçlü ilkyardımcı baş kısımda olmalı, tüm hareketi tek bir sorumlu komutlarla yönetmelidir.

Sedye Taşıma Uygulaması (2 ve 4 Kişi)

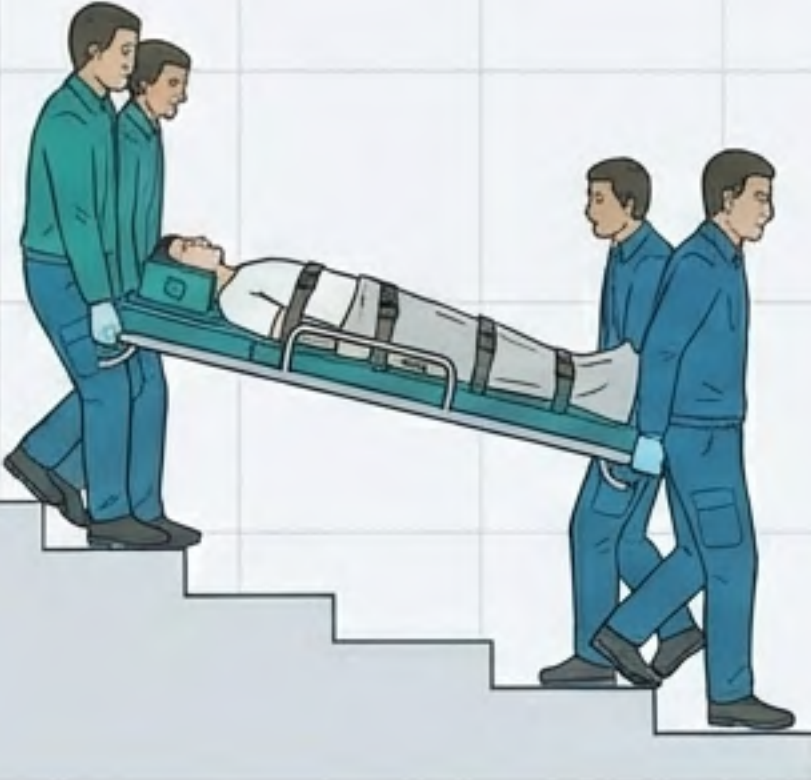
x2-4

Ekip Operasyonu



İki Kişi İle Taşıma

- Sırtlar düz, bacaklar kıvrık şekilde sedyenin iki ucunda iç kısımlarda durulur.
- Önde yürüyen yoldaki olası engelleri haber vermekle sorumludur.



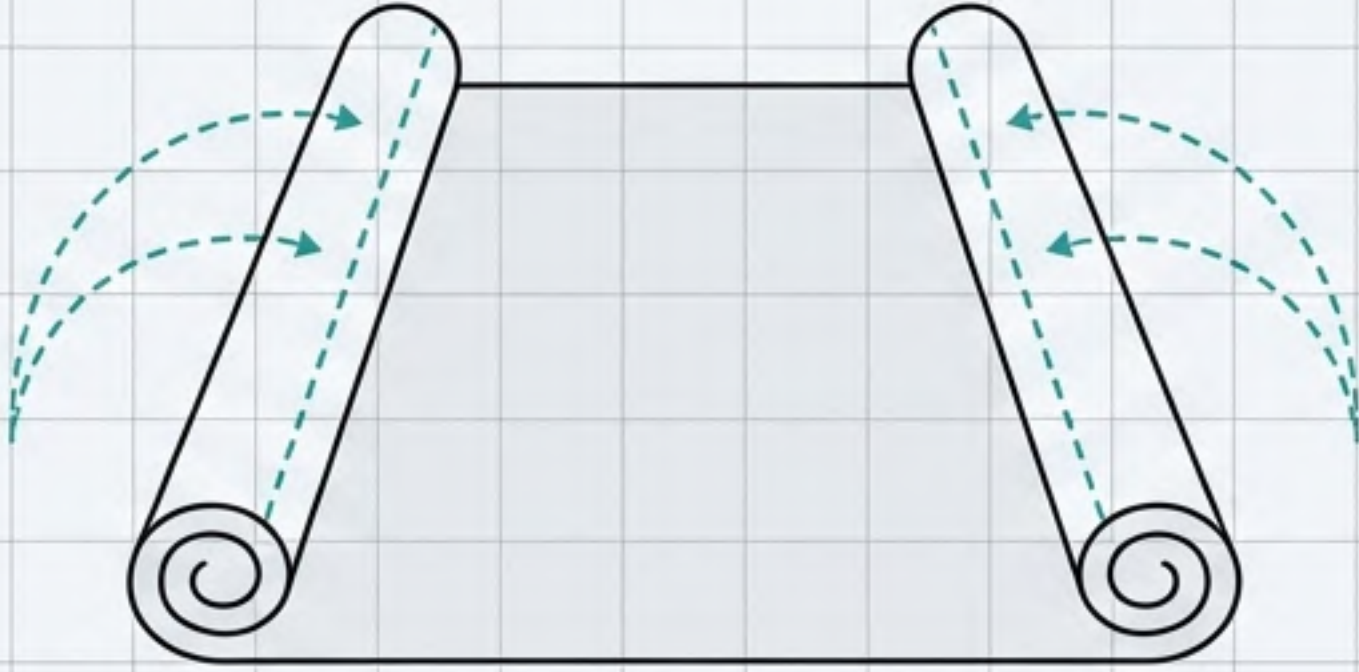
Dört Kişi İle Taşıma (Ağır Durum / Zorlu Yol)

- Dar Alanlar: İlk yardımcılar sırtlarını sedyenin iç kısmına vererek yan yana yürür.
- Merdiven/Yokuş: Sedyenin yatay kalması şarttır. Bunu sağlamak için ayak tarafındakiler sedyeyi omuz hizasında kaldırırken, baş tarafındakiler uyluk hizasında aşağıda tutmalıdır.

Geçici Sedye Oluşturma

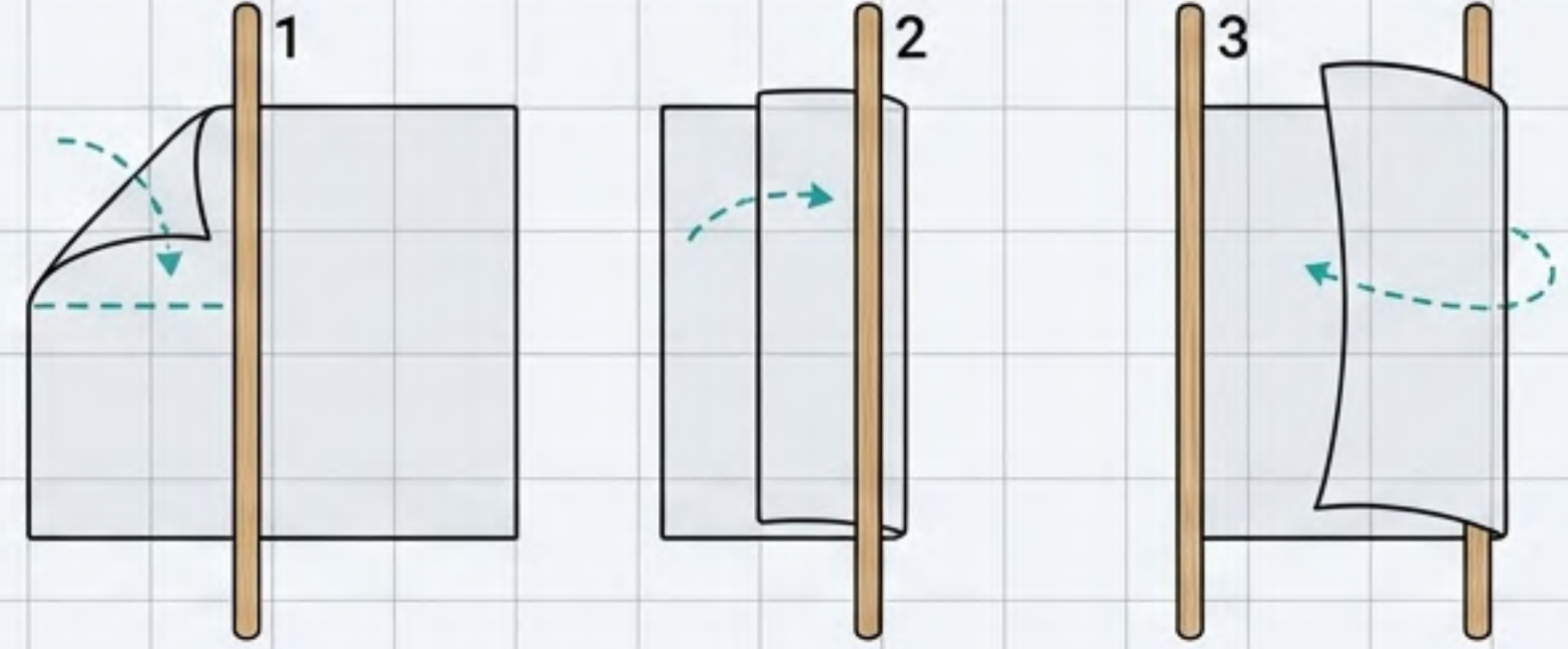
Geçici Donanım

☐ Kontrollü



Tek Battaniye İle (Kısa Mesafe)

- Battaniye yere serilir, kenarları sıkıca rulo yapılarak hastanın yanlarına dayanır ve bu rulolardan tutularak kaldırılır.



Battaniye ve İki Kiriş (Direk) İle

- Battaniye serilir, 1. kiriş battaniyenin 1/3'üne yerleştirilir ve kenar kirişin üzerine katlanır.
- Katlanan kısmın bittiği yere 2. kiriş yerleştirilir.
- Kalan uzun kısım, bu ikinci kirişin üzerini tamamen kaplayacak şekilde geri katlanır. Hasta ortaya yatırılır.

Hayat Kurtaran Taşıma Özet Kontrol Listesi



1. Kendi Güvenliğini Sağla

Biyomekanik kurallara uy. Dizlerini bük, sırtını düz tut. Sen yaralanırsan kimse yardım edemez.



2. Aciliyet Yoksa Dokunma

Yangın, patlama veya solunum durması yoksa hastayı hareket ettirme. Profesyonel yardım bekle.



3. Ekseni Korum

Taşımak zorundaysan "Baş-Boyun-Gövde" hizasını asla bozma. Minimum 6 noktadan destek al.



4. Ekip Ol

Birden fazla kişiyseniz mutlaka bir lider seçin, komutlara uyun ve adımlarınızı (zıt ayakla) senkronize edin.